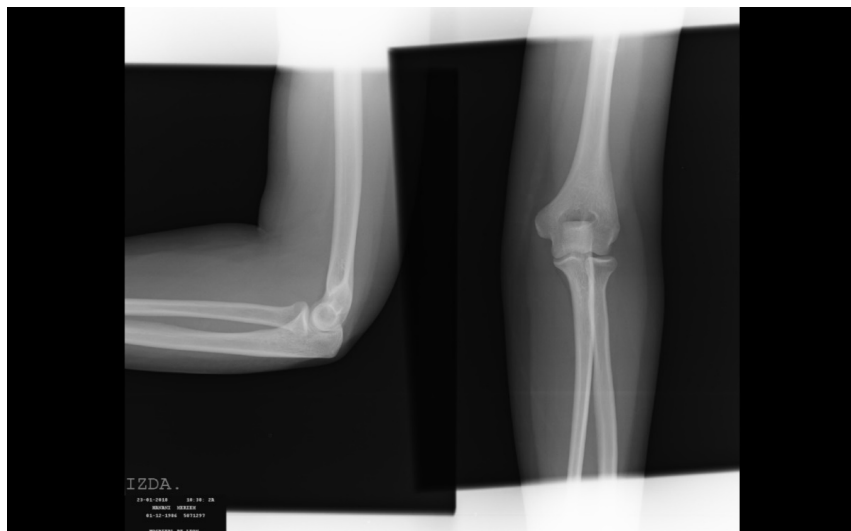


LESIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR: PATOLOGÍA DEL CODO

A. Roces Fernández, G. Alonso Claro, R. Marcos Mesa.



Radiografías anteroposterior y lateral de codo normales.

LUXACIÓN

2ª Articulación que más frecuentemente se luxa en adultos.

Mecanismo lesional: la mayoría ocurren tras caídas sobre la mano con el codo parcialmente extendido. La más frecuente es la luxación posterior. Se asocian con frecuencia a fracturas de la cabeza radial y de la apófisis coronoides (Triada terrible).

Exploración física: deformidad, dolor y limitación funcional. Pérdida de la morfología del triángulo de Nelaton (triángulo equilátero formado por el olecranon – epitroclea – epicóndilo).

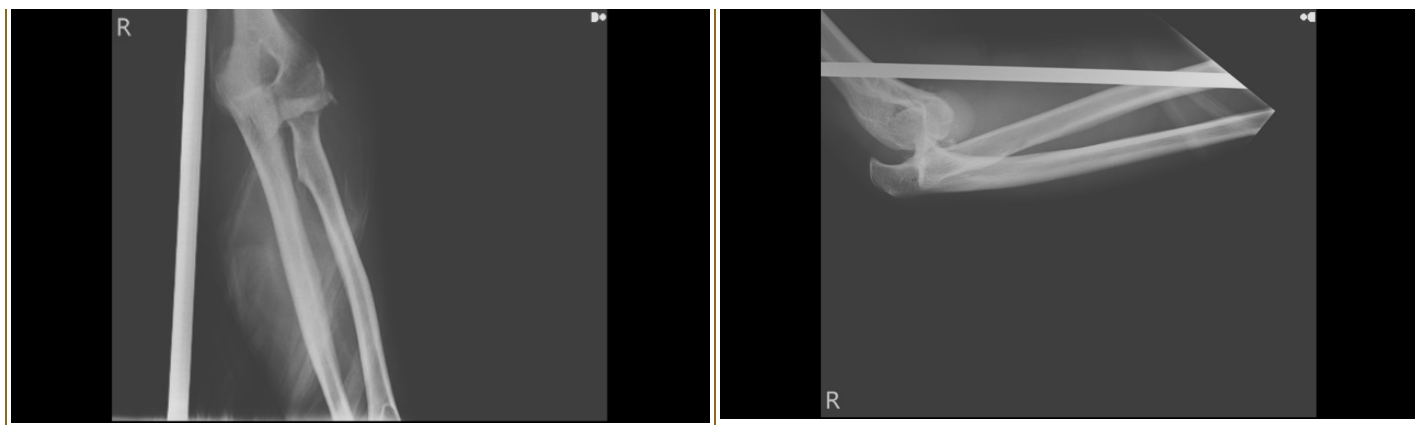
- Descartar lesiones del nervio cubital y del nervio mediano, por tracción.
- Descartar lesión del nervio interóseo anterior (hacer una “O” con el segundo y tercer dedo de la mano).
- Vigilar síndrome compartimental y estado vascular distal.

Pruebas complementarias: Radiografía codo anteroposterior y lateral.

Tratamiento: reducir lo antes posible.

Luxación posterior: método de Parvin, paciente decúbito prono con el codo en flexión se tracciona longitudinal y se presiona sobre el olecranon hacia abajo.

Luxación anterior: tracción más presión hacia atrás y abajo del antebrazo. Tras reducción comprobar de nuevo el estado neurovascular distal, comprobar la estabilidad forzando el varo-valgo y la existencia de bloqueos articulares. Repetir radiografía tras reducción. Si fracturas asociadas o codo inestable tratamiento quirúrgico. Si no existen lesiones óseas ni bloqueos y la articulación es estable, tratamiento conservador, mediante cabestrillo o férula braquiopalmar.



Luxación posterior de codo con fractura de cúpula radial asociada.

FRACTURA DE OLECRANON

Mecanismo lesional: por traumatismo directo o por fractura-arrancamiento (por la fuerza que genera el tendón del tríceps en una caída con el codo semiflexionado).

Exploración física: hemartros, dolor, deformidad y limitación funcional, sobre todo para la extensión activa.

- En ocasiones se puede palpar la discontinuidad del cúbito.
- Explorar el nervio cubital (parestesias en 5º y 4º dedos).
-

Pruebas complementarias: Radiografía codo anteroposterior y lateral.

Tratamiento: la mayoría precisan tratamiento quirúrgico. En caso de fracturas no desplazadas o pacientes con alto riesgo quirúrgico, tratamiento conservador mediante férula braquiopalmar a 120º.



Fractura de olecranon

FRACTURA DE CÚPULA RADIAL

Mecanismo lesional: caída sobre la mano con el codo en extensión.

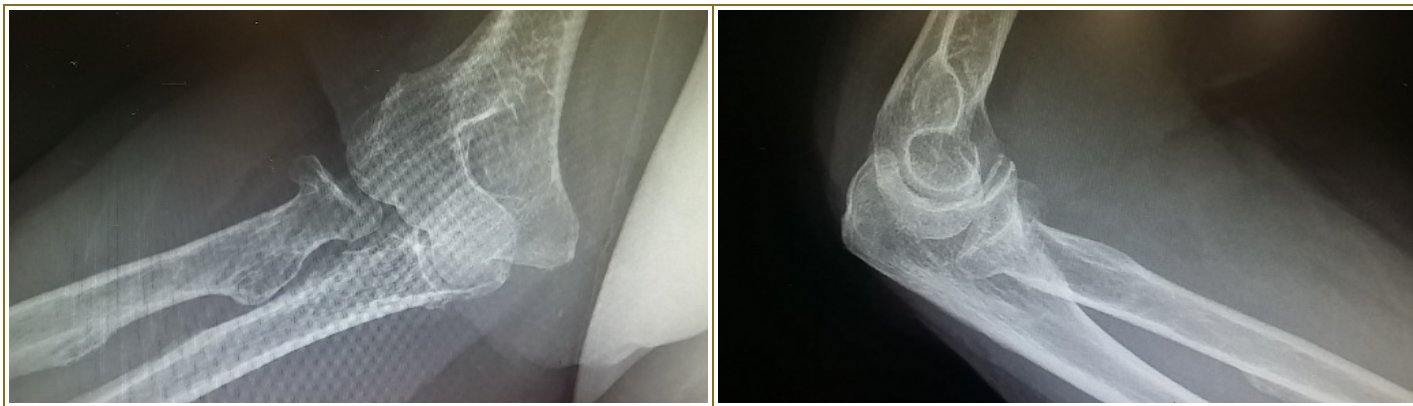
Exploración física: limitación por dolor a la flexo-extensión y sobre todo a la prono-supinación.

- Dolor a la palpación de la cabeza radial.
- Descartar lesiones a nivel del carpo y articulación radiocubital distal.
- Comprobar que no hay bloqueos articulares y que el codo es estable

Pruebas complementarias: Radiografía codo anteroposterior y lateral.

Clasificación: subcapitales o parcelarias (intraarticulares).

Tratamiento: si fracturas no desplazadas y no bloqueo articular, tratamiento conservador mediante férula braquioplamar / cabestrillo. Si fracturas desplazadas, con escalón intraarticular > 2mm o existencia de bloqueo articular, tratamiento quirúrgico.



Fractura parcelar de cúpula radial. Subsidiaria de tratamiento quirúrgico (escalón intraarticular > 2mm)

ROTURA TENDÓN DEL BICEPS

Mecanismo lesional: en pacientes de 40-50 años, tras un sobreesfuerzo al tratar de coger algo pesado.

Exploración física: dolor agudo, chasquido y limitación funcional para la flexión del codo y la supinación. Se aprecia un ascenso de la “bola” y no se palpa bien la inserción del tendón.

Pruebas complementarias: el diagnóstico es clínico. Si existen dudas, hacer ecografía.

Tratamiento: quirúrgico. Conservador sólo en caso de pacientes mayores con baja demanda.